

形成成分的出现无直接关系。所以,尿液分析仪检测和涂片镜检是尿常规检查的两个方面,并互相补充,才能提高阳性检出率。这样才会给临床医生提供及时、准确、可靠的诊断依据。

3.3 尿液分析仪中的隐血既可测定游离的 Hb,又可与完整的红细胞发生反应,还可以与具有过氧化氢酶样活性的物质发生反应而出现假阳性。因此,尿 10A 试纸的隐血与镜检时的 RBC 不相符合率较高,应引起注意。

3.4 尿液分析仪的检测容器受多种因素的影响如空间温度、湿度,试纸条在空间暴露的时间长短等。尿液分析仪对红细胞、白细胞、细菌的检测是靠化学试验间接得到的,特异性不太强,因此在日常工作中,不能忽视尿涂片的作用。不能简单地用尿分析仪法替代人工镜检,人工镜检与分析结果相互参照综合分析,排除相互之间的干扰,减少漏诊和错检,并及时与临床医生相互沟通,才能得到客观准确的结果。

## 必须警惕药物相互作用产生的不良反应

梁福军

中图分类号: R97

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194(2008)17-0355-01

药物相互作用是指某一种药物的作用由于其它药物或化学物质的存在而受到干扰,使该药的疗效发生变化或产生药物不良反应。临床上期望得到的药物相互作用是合并用药,得到疗效提高或(和)毒性减轻的良好效果。但是有些药物合用后,使某药的毒性加大或疗效降低,这就是不良的药物相互作用。最近几年,临床应用证明,不良的药物相互作用当中,出现了严重不良反应,因此应当给予重视。

### 1 心脏意外(心跳骤停或心律失常)

维拉帕米一般不与 B 受体阻断药合用,因均可抑制心肌收缩力、减慢心率和传导,合用后有产生心脏停搏危险。再如:当保钾利尿药与血管紧张素转化酶抑制剂联合应用时,可导致高血钾症,处理不及时会出现心跳骤停的危险。还应注意:异氟醚不宜与去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙肾上腺素合用,由于后者存在增加心率的作用,会出现严重室性心律失常的危险。又如:去乙酰毛花甙与钙盐(静脉用药)合用,可致严重的心律失常,甚至死亡。

### 2 呼吸麻痹

某些氨基苷类抗生素如卡那霉素及多粘菌素也有肌肉松弛作用,与骨骼肌松弛药琥珀胆碱合并使用时,易致呼吸麻痹;或与麻醉药如乙醚、氟烷、甲氧氟烷合并使用,都可造成呼吸肌麻痹和增高神经肌肉阻断的危险性,应注意。

### 3 惊厥

当琥珀胆碱与氟烷合用时,体温突然上升至 42°,称恶性高热,某些患者进而出现惊厥,死亡率很高。再如:三甲丙咪唑与单胺氧化酶抑制剂当大剂量合并使用时,可引起极度兴奋,高热或惊厥发作。还有曲马多与精神抑制剂合用时,个别病人会出现惊厥。

### 4 低血糖昏迷

由于磺酰脲类降糖药有较高的血浆蛋白结合率,因此在蛋白结合上能与其它药物(如保泰松、水杨酸钠、吲哚美辛、青霉素、双香豆素)发生竞争,使游离药物浓度上升而引起低血糖反应,甚至昏迷。另外,左氧氟沙星与口服降糖药同时使用,可能引起血糖失控,包括高血糖与低血糖,因此用药过程中注意监测血糖浓度,一旦发生低血糖反应应立即停用本品,并给予适当处理。

### 5 肝、肾、骨髓等实质性器官损害

异烟肼与酰胺咪嗪联合应用以及利福平与酒精合用,其肝毒性都将增加;头孢唑啉与利尿药合用明显增加其肾毒性;顺铂与其它骨髓抑制剂合用,或先前使用过放射治疗,会增加对骨髓的毒性,需避免合用其他具有肾毒性或耳毒性的药物(如头孢菌素、氨基苷类抗生素、速尿等利尿剂等)。

### 6 出血

阿司匹林与双香豆素合用时,因从血浆蛋白结合部位置换后者,提高游离型双香豆素血浓度,增强其抗凝作用,易致出血;肝素与口服抗凝剂、水杨酸盐、非甾体抗炎药、右旋糖酐以及双嘧达莫不能联合使用,因其可增加出血的危险性

### 7 高血压危象

甲基多巴与单胺氧化酶抑制剂合用,可使血压失控,出现头痛、高血压;再如异烟肼与酒精合用,由于某些葡萄酒中含有酪胺而引起高血压危象。

### 8 低血压休克

胍苯哒嗪与氯甲苯噻嗪合用,可引起严重低血压,甚至休克。另外,我们还应特别注意,中草药与西药之间的相互作用和不良反应。

黑龙江省哈尔滨格拉雷医药经销有限责任公司 (150000)